B3 • Douleur • Échelles & évaluation

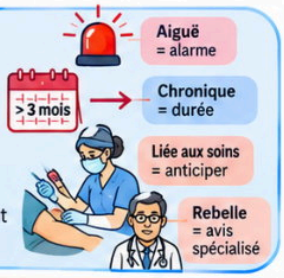


1. DÉFINITION



- **Expérience sensorielle ET émotionnelle désagréable** liée ou ressemblant à celle d'une lésion réelle ou potentielle.
- **Subjective, personnelle,** avec des dimensions **biologiques,** psychologiques et sociales.
- **Absence d'expression ≠ absence de douleur.**
- **Ne pas juger.**

2. TYPES / OBJECTIFS



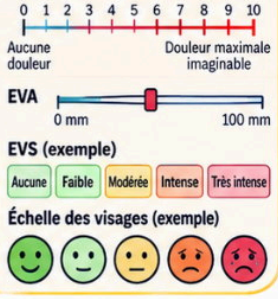
- **Aiguë :** alarme récente, rechercher cause et soulager.
- **Chronique : persiste ou récidive** > 3 mois, améliorer fonction et qualité de vie.
- **Liée aux soins :** anticiper, expliquer, accord, analgésie et réévaluation.
- **Rebelle :** réponse insuffisante malgré traitement adapté, avis spécialisé.

3. QUESTIONNER



- **Où ?** Irradiation ?
- **Depuis quand ?** Durée, crises, évolution ?
- **Comment ?** Brûlure, étau, élancement, décharges ?
- **Intensité au repos ET au mouvement ?**
- **Ce qui aggrave / soulage ?**
- **Traitements** essayés et effets ?
- **Retentissement :** sommeil, mobilité, alimentation, humeur, autonomie.
- **Évaluer aussi signes associés et gravité.**

4. AUTOÉVALUATION PRIORITAIRE (si possible)



- **EN 0–10 :** 0 = aucune douleur, 10 = douleur maximale imaginable.
- **EVA :** curseur, score 0–100 mm.
- **EVS :** catégories verbales selon version.
- **Visages :** échelle validée adaptée à l'âge et à la compréhension, choisie par l'enfant, pas par le soignant.
- Même échelle pour le suivi si possible.

5. HÉTÉROÉVALUATION (si autoévaluation impossible)



- **ALGOPLUS :** douleur aiguë de personne âgée non communicante, 5 items (visage, regard, plaintes, corps, comportement), score 0–5.
- **DOLOPLUS :** douleur prolongée, dimensions somatique, psychomotrice, psychosociale.
- **ECPA :** observation avant ET pendant les soins chez personne âgée.
- **Pédiatrie :** échelle comportementale validée selon âge/situation.
- **Un score ne remplace pas le jugement clinique.**

6. SOULAGER / SURVEILLER



- **Prescription / protocole :** identité, allergies, dose, voie, heure et précautions.
- **Installer, rassurer, distraction, relaxation.**
- **Froid / chaleur seulement si adaptés.**
- **Après traitement :** évaluer douleur et fonction.
- **Surveiller effets indésirables** selon produit (vigilance, respiration, nausées, transit).
- **Inefficacité ou mauvaise tolérance :** transmettre pour réévaluation, ne pas modifier seul.

7. RÔLE IDE



- **Écouter / observer → évaluer → rechercher / signaler la cause → soulager / anticiper → réévaluer → transmettre.**
- **Tracer :** localisation, échelle/score, repos/mouvement, heure, intervention et résultat au délai adapté.
- **Douleur thoracique brutale + sueurs/ irradiation ou détresse : ALERTE immédiate ;** ne pas attendre un score.
- **La mesure de douleur n'efface jamais l'évaluation clinique.**

Synthèse des notes B3 • Appliquer prescriptions, notices et protocoles • UE non précisée